

Graviditetsfysiologi:

- Ökad renal blodgenomströmning (↑ 50-80 %)
- Ökad östrogen nivå (x 15-20) vilket inducerar UGT-enzym
- Ökad fördelningsvolym (vätskeretention, ödem)



Reducerad serumkoncentration av de flesta läkemedel

Karbamazepin	Stabilt (?)
Valproat	↓ Total VPA, men fritt VPA oförändrat
Lamotrigin	↓ 50-60 %
Oxkarb./Eslikarb	↓ 30-40 %
.	
Levetiracetam	↓ 40-60 %
Zonisamid	↓ 20-40 %
Topiramat	↓ 30-40 %
Övriga	Inga data

Provtagningsrutiner

- **Lamotrigin och Levetiracetam;** provtagning var **4e** vecka
- Övriga antiepileptika var **6-8e** vecka
- Zonisamid, lakosamid, perampanel m fl ("nya" AED) – ej testbara

Lamotrigin dosjusteras upp till vecka 20-24 (tot ökning 2-300% vanligt)

Levetiracetam dosjusteras efter vecka 20-24 (dubbling vanligt)

Vid dosjustering under graviditet ska dosminskning ske 3 dagar efter partus och tidigare måldos uppnås på 7-9 dagar (LTG, LEV).

Dosminskning sker varannan dag.

Amning

- **rekommenderas!**
- passerar över i bröstmjölken, men i mycket liten mängd och mindre än under graviditeten
- undvik amning vid benzodiazepin användning, ffa om ej regelbundet intag tidigare.

CAVE: Trött/slö eller skrikig/skakig bebis!!!

- Undvik ny-insättningar och anfallskuperande behandling
- Upprepa säkerhetsinfo till nybliven mamma med anfall!!!

